

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 апреля 2026 г. № 28

**Об изменении постановления Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
от 21 мая 2025 г. № 48**

На основании абзаца девятого части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-ХІІ «О здравоохранении», подпункта 8.3 пункта 8 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, Министерство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 мая 2025 г. № 48 «Об утверждении клинического протокола» следующие изменения:

название изложить в следующей редакции:

«Об утверждении клинических протоколов»;

из преамбулы слова «и подпункта 9.1 пункта 9» исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (детское население) с хроническим риносинуситом» (прилагается);

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (детское население) с острым риносинуситом» (прилагается).»;

клинический протокол «Диагностика и лечение пациентов (детское население) с хроническим риносинуситом», утвержденный этим постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

А.В.Ходжаев

СОГЛАСОВАНО

Брестский областной
исполнительный комитет

Витебский областной
исполнительный комитет

Гомельский областной
исполнительный комитет

Гродненский областной
исполнительный комитет

Могилевский областной
исполнительный комитет

Минский областной
исполнительный комитет

Минский городской
исполнительный комитет

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
21.05.2025 № 48
(в редакции постановления
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь
06.04.2026 № 28)

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ

«Диагностика и лечение пациентов (детское население) с острым риносинуситом»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий клинический протокол устанавливает общие требования к объему оказания специализированной оториноларингологической медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях пациентам (детское население) с острым риносинуситом (далее – ОРС) (шифры по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра – J00 Острый назофарингит (насморк); J01 Острый синусит).

2. Для целей настоящего клинического протокола используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О здравоохранении», Законом Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. № 2570-ХП «О правах ребенка», а также следующий термин и его определение:

ОРС – ряд заболеваний (острый ринит, острый синусит), которые представляют собой воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух (далее – ОНП), обычно сопровождающихся типичными симптомами в различных комбинациях: затруднение носового дыхания (заложенность носа); прозрачные (непрозрачные) окрашенные выделения из носа; головная и (или) лицевая боль (боль в проекции ОНП,

ощущение давления, распирающего); гипосмия; кашель; – с внезапным быстрым развитием симптомов продолжительностью не более 12 недель и полным исчезновением симптомов после выздоровления.

3. По тяжести течения выделяются следующие формы ОРС: легкая, среднетяжелая и тяжелая:

3.1. для легкой формы ОРС характерны: отсутствие лихорадочной реакции; умеренно выраженные симптомы риносинусита (заложенность носа, выделения из носа, кашель), не влияющие или незначительно влияющие на качество жизни пациента (сон, дневная активность, ежедневная деятельность); отсутствие головных болей в проекции ОНП и отсутствие осложнений;

3.2. для среднетяжелой формы ОРС характерны: температура тела не выше 38,0 °С; выраженные симптомы риносинусита (заложенность носа, выделения из носа, кашель), умеренно или значительно влияющие на качество жизни пациента (сон, дневная активность, ежедневная деятельность); ощущение тяжести в проекции ОНП, возникающее при движении головой или наклоне головы; наличие осложнений со стороны среднего уха (острый средний отит); отсутствие внутричерепных или орбитальных осложнений;

3.3. для тяжелой формы ОРС характерны: температура выше 38,0 °С; выраженные или мучительные симптомы риносинусита (заложенность носа, выделения из носа, кашель), умеренно или значительно влияющие на качество жизни пациента (сон, дневная активность, ежедневная деятельность); периодическая или постоянная болезненность в проекции ОНП, усиливающаяся при движении или наклоне головы, пальпации и (или) перкуссии в проекции ОНП; наличие внутричерепных или орбитальных осложнений.

4. По этиологическому фактору и особенностям течения выделяются следующие формы ОРС: вирусный, поствирусный, бактериальный:

4.1. вирусный ОРС – воспалительный процесс в полости носа и ОНП, инициированный одним из респираторных вирусов (риновирусами, коронавирусами, вирусом гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальным вирусом и иными), без характерных для бактериального воспаления изменений в общем анализе крови и биохимическом анализе крови (повышение выше референтных значений скорости оседания эритроцитов (далее – СОЭ) и С-реактивного белка (далее – СРБ)). В большинстве случаев вирусный ОРС протекает в рамках острой респираторной вирусной инфекции и является одним из ее проявлений;

4.2. поствирусный ОРС является этапом формирования вирусно-бактериальных ассоциаций с длительным сохранением типичных симптомов заболевания сроком от 4 до 12 недель;

4.3. бактериальный ОРС характеризуется непрозрачными окрашенными выделениями из носа, головной или лицевой болью либо первоначально тяжелым течением с фебрильной лихорадкой. Диагностическая значимость симптомов повышается при односторонней локализации.

Диагностика бактериального ОРС осуществляется при наличии трех и более симптомов:

продолжительность заболевания более 7–10 дней или усиление симптомов на 5–6 сутки после видимого улучшения (двухволновое течение);

выраженная боль в проекции ОНП и в зубах верхней челюсти;

гнойные выделения в полости носа при передней риноскопии, определение гнойного отделяемого (полоски гноя) в области выводных отверстий пораженных ОНП (при воспалении верхнечелюстной пазухи и лобной пазух – в среднем носовом ходе, при сфеноидите – в верхнем носовом ходе);

повышение уровней СОЭ и СРБ (согласно референтным значениям);

температура тела >38 °С.

При бактериальном ОРС воспалительный процесс может локализоваться в верхнечелюстной (верхнечелюстной синусит), клиновидной (сфеноидит), лобной (фронтит) пазухах и в ячейках решетчатой кости (этмоидит). Возможно одновременное поражение нескольких ОНП (полисинусит): вовлечение в воспалительный процесс всех

ОНП с одной стороны (гемисинусит) или одновременное двустороннее поражение всех ОНП (пансинусит).

5. Медицинская помощь пациентам с ОРС оказывается:

в амбулаторных условиях врачом-педиатром (врачом-педиатром участковым, врачом-педиатром городским (районным));

в стационарных условиях по медицинским показаниям в оториноларингологическом отделении для пациентов детского возраста, на профильных койках в составе других отделений, в педиатрических отделениях или отделениях анестезиологии и реанимации больничных организаций.

К врачу-оториноларингологу в амбулаторных условиях пациент направляется в случае неэффективности лечения в течение 5 дней или персистировании симптомов более 10 дней.

6. Медицинскими показаниями для лечения пациентов с ОРС в стационарных условиях являются:

отсутствие эффекта от лечения в амбулаторных условиях;

тяжелое течение бактериального ОРС;

осложненное течение бактериального ОРС – наличие орбитальных или внутричерепных бактериальных осложнений.

Направление на госпитализацию по экстренным медицинским показаниям осуществляет врач-специалист любой специальности.

7. Фармакотерапия ОРС назначается в соответствии с настоящим клиническим протоколом с учетом всех индивидуальных особенностей пациента, тяжести заболевания, наличия сопутствующей патологии и клинико-фармакологической характеристики лекарственных препаратов (далее – ЛП). При этом учитываются наличие индивидуальных медицинских противопоказаний, аллергологический и фармакологический анамнез.

Применение ЛП осуществляется по медицинским показаниям и в режиме дозирования в соответствии с общей характеристикой ЛП и инструкцией по медицинскому применению (листом-вкладышем). Допускается включение в схему лечения ЛП по медицинским показаниям или в режиме дозирования, не установленной инструкцией по медицинскому применению (листом-вкладышем) и общей характеристикой ЛП (off-label), с дополнительным обоснованием и указанием особых условий назначения, способа применения, дозы, длительности и кратности приема.

8. По решению врачебного консилиума объем лечения ОРС может быть расширен с использованием других методов, не включенных в настоящий клинический протокол, если это осуществляется в интересах пациента по жизненным показаниям.

ГЛАВА 2 ДИАГНОСТИКА ОРС

9. Обязательными диагностическими исследованиями в амбулаторных условиях являются:

сбор анамнеза и жалоб;

пальпация и (или) перкуссия проекции ОНП (лобных, решетчатых, верхнечелюстных пазух);

оценка симметричности глазной щели, лица;

оториноларингологический осмотр;

термометрия тела.

10. Дополнительными диагностическими исследованиями в амбулаторных условиях являются:

обзорная рентгенография ОНП (выполняется при среднетяжелом и тяжелом течении ОРС, при симптомах внутричерепных и орбитальных осложнений; для исключения латентно протекающего одонтогенного синусита, который манифестирует при присоединении риногенных факторов). Обзорная рентгенография ОНП не проводится при вирусном и поствирусном ОРС, а также при нетяжелом неосложненном бактериальном ОРС;

общий анализ крови и определение уровня СРБ (выполняются при диагностике бактериального ОРС, для дифференциальной диагностики с вирусным и поствирусным ОРС) с тяжелым и осложненным течением, в случаях потенциального риска развития гнойных внутричерепных и орбитальных осложнений, детям с тяжелой сопутствующей патологией (иммунодефицитное состояние, лечение иммуносупрессивными ЛП; онкологические и онкогематологические заболевания; врожденные и приобретенные пороки и заболевания сердца, в том числе нарушения ритма, кардиомиопатия; врожденные и приобретенные хронические заболевания легких; болезни эндокринной системы (сахарный диабет, ожирение); хронические тяжелые болезни печени, почек, желудочно-кишечного тракта, нервно-мышечные и неврологические заболевания (нейрокогнитивные нарушения, эпилепсия и иные); врожденные пороки развития и генетические заболевания). Лабораторные исследования при диагностике вирусного и поствирусного ОРС не назначаются;

микробиологическое исследование отделяемого полости носа (выполняется при длительности симптомов бактериального ОРС более 14 дней и при неэффективности антибактериальной терапии) или пунктата пораженной пазухи с определением чувствительности выделенной микробиоты (микобиоты) к антибактериальным и противогрибковым ЛП.

11. Консультация врача-педиатра (врача-педиатра участкового, врача-педиатра городского (районного)) показана при наличии симптомов острой респираторной инфекции и сопутствующей патологии.

При проведении диагностики и лечения ОРС врачом-оториноларингологом в случае наличия у ребенка симптомов острой респираторной инфекции и сопутствующей патологии показана консультация врача-педиатра (врача-педиатра участкового, врача-педиатра городского (районного)).

12. В случае необходимости экстренной госпитализации пациента в амбулаторных условиях выполняются сбор анамнеза и жалоб, оториноларингологический осмотр.

13. Обязательными диагностическими исследованиями в стационарных условиях являются:

13.1. клинические методы исследования:

сбор анамнеза и жалоб;

медицинский осмотр: пальпация и (или) перкуссия проекции ОНП (лобных, решетчатых, верхнечелюстных пазух), оценка симметричности глазной щели, лица;

оториноларингологический осмотр;

термометрия тела;

13.2. лабораторные методы исследования:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

биохимический анализ крови, исследование уровня СРБ;

микробиологическое исследование отделяемого полости носа (выполняется при длительности симптомов бактериального ОРС более 14 дней и при неэффективности антибактериальной терапии) или пунктата пораженной пазухи с определением чувствительности выделенной микробиоты (микобиоты) к антибактериальным и противогрибковым ЛП);

13.3. инструментальные методы исследования:

обзорная рентгенография ОНП (выполняется при отсутствии обзорной рентгенографии ОНП до поступления в больницу организацию, при среднетяжелом и тяжелом течении ОРС, при симптомах внутричерепных и орбитальных осложнений, для исключения латентно протекающего одонтогенного синусита, который манифестирует при присоединении риногенных факторов). Обзорная рентгенография ОНП не проводится при вирусном, а также при нетяжелом неосложненном бактериальном ОРС.

14. Консультация врача-педиатра показана при наличии симптомов острой респираторной инфекции и сопутствующей патологии.

15. Дополнительными диагностическими исследованиями в стационарных условиях являются:

компьютерная томография ОНП или конусно-лицевая компьютерная томография ОНП (выполняется для проведения дифференциальной диагностики и при симптомах внутричерепных осложнений (с расчетом эффективной лучевой дозы));

магнитно-резонансная томография ОНП (выполняется для проведения дифференциальной диагностики и при симптомах внутричерепных осложнений);

консультация врача-детского невролога (при наличии неврологической симптоматики с целью диагностики потенциальных или имеющихся осложнений);

консультация врача-офтальмолога (с целью диагностики потенциальных или имеющихся риногенных орбитальных или внутричерепных осложнений).

16. Объем, последовательность проведения дополнительных диагностических исследований для каждого пациента определяется индивидуально врачом-специалистом с учетом тяжести состояния пациента, характера заболевания, медицинских показаний и медицинских противопоказаний, диагностической значимости исследований и их доступности, экстренного или планового характера хирургического вмешательства.

ГЛАВА 3

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОРС В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

17. При любом характере ОРС для снятия отека, облегчения клинических симптомов и медицинской профилактики осложнений, связанных с нарушением аэрации ОНП и слуховой трубы, назначается один из следующих назальных симпатомиметиков:

17.1. оксиметазолин (капли назальные 0,1 мг/мл; 0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл; спрей назальный 0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл):

детям до 4 недель – раствор 0,1 мг/мл по 1 капле в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

с 5 недель до 1 года – раствор 0,1 мг/мл по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

1–6 лет – раствор 0,25 мг/мл по 1–2 капли или спрей 0,25 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

старше 6 лет – раствор 0,5 мг/мл по 1–2 капли или спрей 0,5 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

17.2. ксилометазолин (капли назальные 0,5 мг/мл; 1 мг/мл; спрей назальный 0,5 мг/мл; 1 мг/мл):

детям в возрасте 1–2 года – капли назальные 0,5 мг/мл, назначаются после оценки соотношения «польза–риск» по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

2–11 лет – капли назальные 0,5 мг/мл по 1–2 капли или спрей назальный 0,5 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

старше 12 лет – капли назальные 1 мг/мл по 2–3 капли или спрей назальный 1 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней.

18. При наличии отделяемого в полости носа для облегчения его эвакуации проводится элиминационно-ирригационная терапия в качестве дополнительного метода лечения: орошение полости носа раствором 9 мг/мл натрия хлорида или стерилизованного раствора морской воды 1–2 раза в сутки; возможно применение спреев на основе стерилизованной океанической или морской воды согласно инструкции по медицинскому применению (листка-вкладышу).

19. При любой форме ОРС назначается один из следующих муколитических ЛП:

19.1. комбинированный ЛП растительного происхождения, включающий: экстракт корня горечавки + цветков первоцвета + травы щавеля + цветков бузины + травы вербены (капли для приема внутрь, сироп для приема внутрь, таблетки, покрытые оболочкой):

детям в возрасте от 2 до 5 лет – капли для приема внутрь по 15 капель 3 раза в сутки, сироп для приема внутрь по 2,1 мл 3 раза в сутки внутрь, 7–14 дней;

детям в возрасте от 6 до 11 лет – капли для приема внутрь по 25 капель 3 раза в сутки, сироп для приема внутрь по 3,5 мл 3 раза в сутки; таблетки, покрытые оболочкой, по 1 таблетке 3 раза в сутки внутрь, 7–14 дней;

детям старше 12 лет – капли для приема внутрь по 50 капель 3 раза в сутки, сироп для приема внутрь по 7,0 мл 3 раза в сутки; таблетки, покрытые оболочкой, по 2 таблетки 3 раза в сутки внутрь 7–14 дней;

19.2. аэрозоль 10 мл, содержащий ацетилцистеин 10 мг, туаминогептана сульфат 5 мг, спрей назальный 1 % + 0,5 %:

детям старше 12 лет – по 1 дозе (1 нажатие на клапан) 3–4 раза в сутки в каждый носовой ход не более 7 дней;

19.3. ацетилцистеин (для детей старше 2 лет), сироп 20 мг/мл, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг, 200 мг, таблетки шипучие 200 мг, 600 мг – детям 2–12 лет – 100 мг 3 раза в сутки или 200 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 лет – 200 мг 2 раза в сутки, старше 12 лет – 200 мг 3 раза в сутки, продолжительность лечения – до 14 дней в зависимости от клинических симптомов.

20. В первые три дня заболевания назначается один из следующих антигистаминных ЛП:

20.1. цетиризина гидрохлорид (капли для приема внутрь 10 мг/мл, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, капсулы 5 мг, 10 мг) – детям возрасте от 6 месяцев до 1 года по 5 капель 1 раз в сутки; детям в возрасте от 1 года до 2 лет по 5 капель 1–2 раза в сутки; детям в возрасте от 2 до 6 лет по 5 капель 2 раза в сутки; у пациентов в возрасте от 6 до 12 лет по 10 мг 1 раз в сутки или по 10 капель 2 раза в сутки; у пациентов в возрасте 12 лет и старше по 10 мг или 20 капель 1 раз в сутки; внутрь 3 дня (у пациентов с сочетанной аллергической патологией курс может быть продлен);

20.2. лоратадин (сироп 5 мг/5 мл, таблетки 10 мг) – детям в возрасте от 2 до 6 лет (при массе тела 30 кг и менее) по 5 мл 1 раз в сутки; детям в возрасте 6 лет и старше (при массе тела более 30 кг) по 10 мг или 10 мл сиропа 1 раз в сутки; внутрь 3 дня (у пациентов с сочетанной аллергической патологией курс может быть продлен);

20.3. дезлоратадин (сироп 0,5 мг/мл, таблетки 5 мг) – детям в возрасте от 6 до 11 месяцев по 2 мл сиропа 1 раз в сутки; детям в возрасте от 11 месяцев до 5 лет по 2,5 мл сиропа 1 раз в сутки; детям в возрасте от 5 до 12 лет по 5 мл сиропа 1 раз в сутки; детям в возрасте 12 лет и старше по 5 мг или 10 мл сиропа 1 раз в сутки; внутрь 3 дня (у пациентов с сочетанной аллергической патологией курс может быть продлен);

20.4. левоцетиризин (капли для приема внутрь 5 мг/мл, таблетки 5 мг) – детям в возрасте от 2 до 6 лет по 5 капель 2 раза в сутки; детям в возрасте от 6 до 12 лет по 5 мг или по 10 капель 2 раза в сутки; детям в возрасте 12 лет и старше по 5 мг или 20 капель 1 раз в сутки; внутрь 3 дня (у пациентов с сочетанной аллергической патологией курс может быть продлен);

20.5. хифенадин (таблетки 10 мг, 25 мг, 50 мг) – детям в возрасте до 3 лет по 5 мг 2–3 раза в сутки; детям в возрасте от 3 лет до 7 лет по 10 мг 2 раза в сутки; детям в возрасте от 7 лет до 12 лет по 10–15 мг 2–3 раза в сутки; детям в возрасте 12 лет и старше по 25–50 мг 2–4 раза в сутки; внутрь 3 дня (у пациентов с сочетанной аллергической патологией курс может быть продлен).

21. При поствирусном ОРС (более 10 дней, но без признаков тяжелой бактериальной инфекции) назначается один из следующих интраназальных глюкокортикоидов (далее – ИнГК):

мометазон (спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 140 доз): детям в возрасте от 2 до 11 лет – рекомендуемая терапевтическая доза составляет 1 впрыскивание (50 мкг) 1 раз в сутки в каждую половину носа (общая суточная доза – 100 мкг); детям старше 12 лет – рекомендуемая терапевтическая доза составляет 2 впрыскивания (100 мкг) 1 раз в сутки в каждую половину носа (общая суточная доза – 200 мкг);

флутиказона пропионат (спрей назальный дозированный 50 мкг/доза 120 доз), детям в возрасте от 4 до 11 лет: рекомендованная начальная доза – по 1 распылению (50 мкг) в каждую половину носа 1 раз в сутки (100 мкг), при отсутствии желаемого эффекта при

применении 1 распыления в каждую половину носа в сутки возможно повышение дозы до 2 распылений в каждую половину носа в сутки (200 мкг в сутки), при достижении адекватного контроля симптомов рекомендуется снизить дозу до 1 распыления в каждую половину носа 1 раз в сутки (100 мкг); детям в возрасте 12 лет и старше: рекомендованная начальная доза – по 2 распыления (100 мкг в одном распылении) в каждую половину носа 1 раз в сутки (200 мкг), в некоторых случаях – по 2 распыления в каждую половину носа 2 раза в сутки, максимальная суточная доза не должна превышать 4 распыления в каждую половину носа.

ИнГК* назначаются на 10–15 дней в зависимости от клинических симптомов. При вирусном ОРС до 10 дней течения ИнГК не назначаются.

* Off-label.

22. Медицинскими показаниями к системной антибиотикотерапии при ОРС являются:

бактериальный синусит;

изначально тяжелое течение: лихорадка $>39^{\circ}\text{C}$; головные и лицевые боли; гнойные выделения из носа, сохраняющиеся в течение 3–4 дней;

осложненное течение, угроза развития орбитальных или внутричерепных осложнений (нарастающие реактивные явления в мягких тканях орбиты и лица).

23. ЛП первой линии является амоксициллин (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 25 мг/мл, 50 мг/мл, таблетки диспергируемые 125 мг, 250 мг, 500 мг, таблетки (таблетки, покрытые оболочкой) 250 мг, 500 мг, капсулы 250 мг, 500 мг). Назначается при отсутствии данных о приеме данного ЛП в предыдущие 3 месяца и непереносимости аминопенициллинов в анамнезе в следующих дозировках:

детям до 12 лет с массой тела менее 40 кг – внутрь 45–60 мг/кг в сутки в 2–3 приема;

детям старше 12 лет или с массой тела более 40 кг – внутрь 500–1000 мг в сутки, в 2–3 приема.

Терапия амоксициллином продолжается 2 дня после исчезновения симптомов (но не менее 7 дней). Критерием эффективности антибактериальной терапии является положительная динамика основных симптомов ОРС (головной боли, выделений, заложенности носа), показателей термометрии и общего состояния пациента в течение первых 72 часов приема антибактериального ЛП.

24. ЛП второй линии является один из следующих ЛП (назначается при отсутствии клинического эффекта через 72 часа от начала лечения антибактериальными ЛП первой линии):

24.1. амоксициллин/клавулановая кислота (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 25 мг/6,25 мг/мл, 40 мг/5,7 мг/мл, 50 мг/12,5 мг/мл, 80 мг/11,4 мг/мл, 120 мг/8,58 мг/мл; таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг, 500 мг/125 мг, 875 мг/125 мг) в следующих дозировках:

детям до 12 лет с массой тела менее 40 кг – внутрь 45–60 мг/кг в сутки (расчет по амоксициллину) в 2–3 приема;

детям старше 12 лет или с массой тела более 40 кг – внутрь 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки.

Курс лечения – 10–14 дней;

24.2. цефуроксим (гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5 мл, таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, 250 мг):

детям с 3-месячного возраста до 12 лет или с массой тела менее 40 кг – 30 мг/кг в сутки, максимально – 1 г в сутки, внутрь на 2 приема;

детям с массой тела 40 кг и более – 1 г в сутки внутрь на 2 приема.

Курс лечения – 7–14 дней;

24.3. цефдинир (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 125 мг/5 мл, 250 мг/5 мл, капсулы 300 мг):

детям в возрасте с 6 месяцев и до 12 лет или с массой тела менее 40 кг – 14 мг/кг в сутки, внутрь на 2 приема;

детям с массой тела 40 кг и более – 600 мг в сутки внутрь на 2 приема.

Курс лечения – 10 дней;

24.4. цефподоксим (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 200 мг): детям старше 12 лет – 400 мг в сутки внутрь на 2 приема. Максимальная суточная доза 400 мг. Курс лечения – 10 дней.

25. Медицинскими показаниями для назначения антибактериальных ЛП третьей линии являются:

непереносимость бета-лактамов антибактериальных ЛП;

предшествующий прием антибактериальных ЛП первой и второй линии в предыдущие 3 месяца;

неэффективность бета-лактамов антибактериальных ЛП через 72 часа.

26. В качестве антибактериальных ЛП третьей линии назначается один из следующих ЛП:

26.1. кларитромицин (гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл, 50 мг/мл, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 25 мг/мл, таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, 500 мг). Суточная доза составляет 15 мг/кг в сутки (7,5 мг/кг каждые 12 часов) внутрь, максимальная доза – 500 мг 2 раза в сутки. Кратность приема составляет:

детям с массой тела 8–11 кг (1–2 года) – 62,5 мг каждые 12 часов;

детям с массой тела 12–19 кг (3–6 лет) – 125 мг каждые 12 часов;

детям с массой тела 20–29 кг (7–9 лет) – 187,5 мг каждые 12 часов;

детям с массой тела 30–40 кг (10–12 лет) – 250 мг каждые 12 часов.

Суспензия предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, таблетки – детям старше 12 лет. Курс лечения – до 10 дней;

26.2. азитромицин:

порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл, 10 мг/мл, 25 мг/мл. Обычная суточная доза 10 мг/кг массы тела 1 раз в сутки; детям с массой тела: 5 кг – 50 мг; 6 кг – 60 мг; 7 кг – 70 мг; 8 кг – 80 мг; 9 кг – 90 мг; 10–14 кг – 100 мг; 15–24 кг – 200 мг; 25–34 кг – 300 мг; 35–44 кг – 400 мг; 45 кг – 500 мг. Курс лечения – до 10 дней;

таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, 250 мг, 500 мг – внутрь детям старше 12 лет с массой тела более 45 кг: по 500 мг 1 раз в сутки; детям от 3 до 12 лет с массой тела менее 45 кг из расчета 10 мг/кг массы тела 1 раз в сутки; детям с массой тела 18–30 кг – 250 мг 1 раз в сутки, детям с массой тела 31–44 кг – 375 мг 1 раз в сутки.

Таблетки азитромицина противопоказаны детям:

в возрасте до 12 лет с массой тела менее 45 кг (для таблеток 500 мг);

до 3 лет (для таблеток 125 мг).

Детям младше 3 лет назначается порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

Курс лечения – до 10 дней;

26.3. клиндамицин (капсулы, 300 мг), внутрь детям старше 6 лет 8–25 мг/кг в сутки в 3–4 приема. Курс лечения – до 10 дней.

27. Медицинскими показаниями к жаропонижающей терапии являются:

высокая лихорадка (39 °С и выше) вне зависимости от возраста ребенка;

температура тела до 38 °С у детей с фебрильными судорогами в анамнезе, врожденными пороками сердца, перинатальными поражениями центральной нервной системы и их последствиями, эпилепсией или эпилептическим синдромом и другими прогностически неблагоприятными факторами риска;

температура тела до 38 °С у детей, субъективно плохо переносящих лихорадку.

28. С целью снижения температуры тела и (или) для купирования болевого синдрома применяется один из следующих ЛП:

28.1. парацетамол:

раствор для приема внутрь (сироп) 30 мг/мл; сироп 24 мг/мл: детям в возрасте от 1 месяца до 12 лет с массой тела от 4 кг 10–15 мг/кг каждые 6 часов. Суточная доза 40–60 мг/кг в сутки;

суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл назначается детям следующим образом:
в возрасте от 2 до 3 месяцев – около 2 мл суспензии по назначению врача-специалиста (около 50 мг парацетамола);
от 3 месяцев до 1 года – 2,5–5 мл суспензии (1/2–1 чайной ложки, 60–120 мг парацетамола);
от 1 года до 6 лет – 5–10 мл суспензии (1–2 чайной ложки, 120–240 мг парацетамола);
от 6 до 14 лет – 10–20 мл суспензии (2–4 чайной ложки, 240–480 мг парацетамола);
суппозитории ректальные 50 мг, 80 мг, 100 мг, 125 мг, 150 мг, 250 мг, 300 мг – детям от 3 месяцев 10–15 мг/кг массы тела 3–4 раза в сутки (каждые 6 часов) максимальная суточная доза не должна превышать 60 мг/кг массы тела;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 500 мг – детям в возрасте 6–11 лет разовая доза 10–15 мг/кг массы тела, максимальная суточная доза не должна превышать 60 мг/кг массы тела (назначается по 200–500 мг каждые 4–6 часов) при необходимости (интервал между приемами не менее 4 часов), не более 4 доз в сутки; детям старше 12 лет до 500–1000 мг каждые 4–6 часов, максимальная суточная доза 4000 мг;

28.2. ибупрофен:

суспензия для внутреннего применения 100 мг/5 мл, суспензия для внутреннего применения 200 мг/5 мл: детям старше 3 месяцев с массой тела не менее 5 кг – суточная доза 20–30 мг/кг, разделенная на несколько равных доз. Интервал между дозами составляет 6–8 часов. Максимальная суточная доза – 30 мг/кг в сутки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 400 мг; капсулы 200 мг, 400 мг, детям старше 12 лет – 200–400 мг до 3 раз в сутки;

суппозитории ректальные 60 мг: детям от 3 месяцев до 2 лет с массой тела не менее 6 кг максимальная суточная доза 20–30 мг/кг в 3–4 приема; детям 3–9 месяцев – 60 мг 3 раза в сутки через 6–8 часов; детям от 9 месяцев до 2 лет с массой тела 8–12 кг 60 мг 4 раза в сутки.

29. В качестве дополнительного метода лечения, который выполняется врачом-оториноларингологом (при наличии технических возможностей) используется вакуумное дренирование ОНП (с использованием вакуумного аспиратора), которое заключается в одновременном введении в одну половину носа промывающего раствора и вакуумного «аспирирования» его из второй, обеспечивая циркуляцию раствора между пазухами и его воздействие непосредственно на очаг воспаления. Предварительно, за 10–15 минут до процедуры должны быть использованы назальные симпатомиметики согласно пункту 17 настоящего клинического протокола.

30. Методом хирургического вмешательства при лечении пациентов с ОРС является пункция верхнечелюстной пазухи, которая осуществляется в соответствии со следующими медицинскими показаниями:

30.1. горизонтальный уровень жидкости на рентгенографии ОНП;

30.2. отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии;

30.3. выраженный болевой синдром, связанный с блоком соустья (с учетом данных рентгенографии (тотальное, субтотальное затемнение, в том числе с горизонтальным уровнем);

30.4. тяжелое течение острого верхнечелюстного синусита (с учетом данных рентгенографии (тотальное, субтотальное затемнение, в том числе с горизонтальным уровнем);

30.5. необходимость подтверждения риногенного и внутричерепного осложнения в сомнительных случаях;

30.6. взятие биологического материала из верхнечелюстной пазухи для бактериологического исследования.

31. Физиотерапевтическое лечение ОРС назначается по медицинским показаниям.

ГЛАВА 4

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОРС В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

32. Пациентам, не принимавшим антибактериальную терапию в течение 3 предыдущих месяцев, назначается один из следующих ЛП:

32.1. амоксициллин/клавулановая кислота (порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для внутреннего применения) 25 мг/6,25 мг/мл, 40 мг/5,7 мг/мл, 50 мг/12,5 мг/мл, 80 мг/11,4 мг/мл, 120 мг/8,58 мг/мл; таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/125 мг, 500 мг/125 мг, 875 мг/125 мг):

детям до 12 лет с массой тела менее 40 кг – внутрь 45–60 мг/кг в сутки (расчет по амоксициллину) в 2–3 приема;

детям старше 12 лет или с массой тела более 40 кг – внутрь 500/125 мг 3 раза в сутки или 875/125 мг 2 раза в сутки;

курс лечения – 10–14 дней;

32.2. амоксициллин/клавулановая кислота (порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/100 мг, 1000 мг/200 мг):

детям до 3 месяцев с массой тела 4 кг – 50/10 мг/кг в сутки внутривенно 2 раза в сутки;

детям старше 3 месяцев – 75/15 мг/кг в сутки внутривенно 3 раза в сутки;

детям старше 12 лет и массой тела 40 кг и более – 3000/600 мг в сутки внутривенно 3 раза в сутки;

курс лечения – 10–14 дней;

32.3. ампициллин/сульбактам натрия (порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 500 мг/250 мг, 1000 мг/500 мг), рекомендуемая суточная доза – 100–200 мг ампициллина/50–100 мг сульбактама/кг массы тела в сутки (в сумме содержание ампициллина и сульбактама 150–300 мг/кг), внутривенно инфузией, в одинаковых разовых дозах каждые 6–8 часов; у детей с массой тела 40 кг и более общая доза сульбактама не должна превышать 4 г в сутки. Курс лечения – 7–10 дней. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии).

33. Пациентам со множественной сопутствующей патологией или при наличии в анамнезе в течение 3 предыдущих месяцев приема антибактериальных ЛП стартовой терапии назначаются ЛП по одной из следующих схем:

33.1. цефуроксим (гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг/5 мл, таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, 250 мг):

детям с 3-месячного возраста до 12 лет или с массой тела менее 40 кг: 30 мг/кг в сутки, максимально – 1 г в сутки, внутрь на 2 приема;

детям с массой тела 40 кг и более – 1 г в сутки внутрь на 2 приема;

курс лечения – 7–14 дней;

33.2. цефотаксим (порошок для приготовления раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций 500 мг, 1000 мг):

детям от 1 месяца до 12 лет или с массой тела менее 50 кг внутривенно 50–150 мг/кг в сутки, разделенные на 2–4 введения;

детям старше 12 лет и массой тела более 50 кг внутривенно по 1 г каждые 12 часов;

курс лечения – 7–10 дней;

33.3. цефтриаксон* (порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 250 мг, 500 мг, 1000 мг, 2000 мг):

детям от 15 дней до 12 лет (масса тела менее 50 кг) – 50–80 мг/кг массы тела 1 раз в сутки;

детям старше 12 лет и массой тела более 50 кг – 1–2 г в сутки (в одно введение);

курс лечения – 7–10 дней;

* Исключительно при отсутствии другого эффективного ЛП с учетом чувствительности микрофлоры.

33.4. цефтазидим, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 500 мг, 1000 мг, 2000 мг: детям с массой тела 40 кг и более: непрерывная инфузия с нагрузочной дозой 2,0 г с последующим непрерывным введением в дозе 4–6 г каждые 24 часов; прерывистое внутривенное введение: при тяжелом течении ОРС с внутричерепными осложнениями – 2 г каждые 8 часов; детям с массой тела менее 40 кг в возрасте старше 2 месяцев: непрерывная инфузия с нагрузочной дозой 60–100 мг/кг с последующим непрерывным введением 100–200 мг/кг в сутки, максимум 6 г в сутки; прерывистое внутривенное введение 150 мг/кг в сутки в 3 отдельные дозы, максимум 6 г в сутки. У пациентов с тяжелыми инфекциями на 50 % увеличивается разовая доза или частота приема; курс лечения – 7–10 дней;

33.5. цефепим, порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инъекций) 500 мг, 1000 мг, 2000 мг: детям старше 12 лет (с массой тела более 40 кг) – 1–2 г внутривенно каждые 12 часов; детям в возрасте от 2 месяцев до 12 лет (с массой тела менее 40 кг): при тяжелых инфекциях – 50 мг/кг массы тела каждые 12 часов; очень тяжелых инфекциях (сепсис, бактериальный менингит, эмпирическое лечение эпизодов фебрильной нейтропении) – 50 мг/кг массы тела каждые 8 часов. Курс лечения – 7–10 дней.

34. При непереносимости бета-лактамов антибактериальных ЛП назначается один из следующих антибактериальных ЛП:

34.1. кларитромицин:

гранулы для приготовления суспензии для внутреннего применения (для приема внутрь) 25 мг/мл, 50 мг/мл, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 25 мг/мл, таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, 500 мг. Суспензия предназначена для детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, таблетки – детям старше 12 лет.

Обычная суточная доза составляет 15 мг/кг в сутки (7,5 мг/кг каждые 12 часов) внутрь, максимальная доза – 500 мг 2 раза в сутки:

детям весом 8–11 кг (1–2 года) – 62,5 мг каждые 12 часов;

весом 12–19 кг (3–6 лет) – 125 мг каждые 12 часов;

весом 20–29 кг (7–9 лет) – 187,5 мг каждые 12 часов;

весом 30–40 кг (10–12 лет) – 250 мг каждые 12 часов;

весом более 40 кг (старше 12 лет) – 250 мг каждые 12 часов;

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг (детям старше 12 лет) – 500 мг 2 раза в сутки внутривенно, максимальная суточная доза – 1 г;

курс лечения – до 10 дней;

34.2. азитромицин:

порошок для приготовления суспензии для внутреннего применения 5 мг/мл, 10 мг/мл, 25 мг/мл. Обычная суточная доза 10 мг/кг массы тела 1 раз в сутки; детям с массой тела: 5 кг – 50 мг; 6 кг – 60 мг; 7 кг – 70 мг; 8 кг – 80 мг; 9 кг – 90 мг; 10–14 кг – 100 мг; 15–24 кг – 200 мг; 25–34 кг – 300 мг; 35–44 кг – 400 мг; 45 кг – 500 мг;

таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, 250 мг, 500 мг – внутрь детям старше 12 лет с массой тела более 45 кг: по 500 мг 1 раз в сутки; детям от 3 до 12 лет с массой тела менее 45 кг из расчета 10 мг/кг массы тела 1 раз в сутки; детям с массой тела 18–30 кг – 250 мг, с массой тела 31–44 кг – 375 мг;

лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для инфузий 500 мг – 10 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в первый день внутривенно, максимальная суточная доза – 500 мг; 5 мг/кг массы тела 1 раз в сутки в последующие дни внутривенно, максимальная суточная доза – 250 мг; переход на пероральную терапию через 1–2 дня после нормализации температуры тела и наличия положительной динамики лечения;

курс лечения – до 10 дней;

34.3. клиндамицин (капсулы, 300 мг), внутрь детям старше 6 лет 8–25 мг/кг в сутки в 3–4 приема. Курс лечения – до 10 дней.

35. При наличии признаков нозокомиального синусита (на фоне искусственной вентиляции легких, передней или задней тампонады носа, назогастрального зонда),

внутрибольничной инфекции, тяжелом течении ОРС с внутричерепными и (или) орбитальными осложнениями назначается один из следующих антибактериальных ЛП:

35.1. имипенем/циластатин, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инфузий) 250 мг/250 мг, 500 мг/500 мг, детям в возрасте старше 1 года обычно рекомендованная доза составляет 15/15 мг/кг или 25/25 мг/кг каждые 6 часов. В случае, если инфекция вызвана менее чувствительными видами бактерий (например, *Pseudomonas aeruginosa*), а также при очень тяжелой инфекции (например, дети с нейтропенической лихорадкой) рекомендованная доза составляет 25/25 мг/кг каждые 6 часов. Максимальная суточная доза для лечения инфекций, вызванных полностью чувствительными микроорганизмами, составляет 2,0 г в сутки, инфекций с умеренной восприимчивостью микроорганизмов (в первую очередь вызванными некоторыми штаммами *P. aeruginosa*) – 4,0 г в сутки. Курс лечения – до 10 дней. Не применяется у детей с инфекциями центральной нервной системы из-за риска судорог и у детей с массой тела менее 30 кг с нарушениями функции почек. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии);

35.2. меропенем, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения (для инъекций) 500 мг, 1000 мг, детям с массой тела более 50 кг – 500 мг–1 г каждые 8 часов; при очень тяжелых инфекциях рекомендуемая доза для детей старше 10 лет – до 2 г 3 раза в сутки, для детей – до 40 мг/кг 3 раза в сутки. Детям в возрасте от 3 месяцев до 11 лет с массой тела менее 50 кг – 10–20 мг/кг каждые 8 часов. Детям с массой тела более 50 кг с почечной недостаточностью: при клиренсе креатинина 26–50 мл/мин – стандартная доза каждые 12 часов; 10–25 мл/мин – 1/2 дозы каждые 12 часов; менее 10 мл/мин – 1/2 дозы каждые 24 часа. Курс лечения – до 10 дней. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии);

35.3. эртапенем, лиофилизированный порошок (лиофилизат) для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения (для инфузий) 1000 мг, детям от 13 до 17 лет – 1 г 1 раз в сутки внутривенно. Детям в возрасте от 3 месяцев до 12 лет – 15 мг/кг 2 раза в сутки (не превышая дозу 1 г в сутки) внутривенно. Курс лечения – до 10 дней. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии);

35.4. пиперациллин/тазобактам, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2000 мг/250 мг, 4000 мг/500 мг, детям в возрасте от 2 до 12 лет – по 100 мг/кг (по пиперациллину) 3 раза в сутки, детям в возрасте старше 12 лет – по 4 г (по пиперациллину) 3 раза в сутки, максимальная суточная доза 13,5 г, курс 10 дней. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии).

36. При подозрении на MRSA-инфекцию назначается один из следующих ЛП:

36.1. линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл, детям от рождения до 12 лет – 30 мг/кг в сутки внутривенно на 3 введения, дети 12 лет старше – 1200 мг на 2 введения в сутки внутривенно. Курс лечения – до 10 дней. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии);

36.2. ванкомицин, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 мг, 1000 мг, порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг, 1000 мг, детям от 1 месяца до 12 лет: 40–60 мг/кг в сутки внутривенно на 4 введения в сутки, детям старше 12 лет – 15–20 мг/кг массы тела каждые 8–12 часов внутривенно, максимальная суточная доза 6 г. Курс лечения – до 10 дней. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии).

37. При высоком уровне карбапенем-резистентной грам-минус флоры назначается карбапенем с антисинегнойной активностью (меропенем, имипенем/циластатин) в сочетании с колистиметатом натрия:

колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для ингаляций 1 000 000 ЕД, порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и ингаляций 2 000 000 МЕ, 3 000 000 МЕ, 4 500 000 МЕ. Назначается по решению врачебного консилиума (за исключением бригад скорой медицинской помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии);

ингаляционное применение коллистиметата натрия: детям в возрасте до 2 лет – по 500 000–1 000 000 МЕ ингаляционно 2 раза в сутки, детям старше 2 лет – 1 000 000–2 000 000 МЕ ингаляционно 2 раза в сутки, длительность курса определяется индивидуально и зависит от клинического состояния пациента;

парентеральное применение коллистиметата натрия: детям с массой тела ≤ 40 кг – 75 000–150 000 МЕ/кг в сутки, детям с массой тела ≥ 40 кг и подросткам – 9 000 000 МЕ/кг в сутки. Суточная доза распределяется на 23 приема. Курс лечения составляет 5 дней.

38. С целью снижения температуры тела и (или) для купирования болевого синдрома применяются ЛП, указанные в пункте 28 настоящего клинического протокола.

39. В случае невозможности применения или при отсутствии эффекта от приема парацетамола и ибупрофена внутрь или при наличии обстоятельств, затрудняющих их прием внутрь, парацетамол (раствор для инфузий 10 мг/мл) назначается внутривенно медленно из расчета на массу тела:

до 10 кг – разовая доза 7,5 мг/кг, максимальная суточная доза – 30 мг/кг;

10–33 кг – разовая доза 15 мг/кг, максимальная суточная доза – 60 мг/кг, не более 2 г;

33–50 кг – разовая доза 15 мг/кг, максимальная суточная доза – 60 мг/кг, не более 3 г;

более 50 кг – разовая доза 1,0 г, максимальная суточная доза – 4,0 г;

более 50 кг с дополнительными факторами риска гепатотоксичности – разовая доза 1,0 г, максимальная суточная доза – 3,0 г.

40. Для купирования болевого синдрома используется кеторолак (с 16 лет), раствор для внутримышечного введения 30 мг/мл в ампулах по 1 мл, разовая доза – 0,5 мг/кг массы тела внутривенно или внутримышечно. Максимальная суточная доза – 90 мг.

41. При любом характере ОРС для снятия отека, облегчения клинических симптомов и медицинской профилактики осложнений, связанных с нарушением аэрации ОНП и слуховой трубы, назначается один из следующих назальных симпатомиметиков:

41.1. оксиметазолин (капли назальные 0,1 мг/мл; 0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл; спрей назальный 0,25 мг/мл; 0,5 мг/мл):

детям до 4 недель – раствор 0,1 мг/мл по 1 капле в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

с 5 недели до 1 года – раствор 0,1 мг/мл по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

1–6 лет – раствор 0,25 мг/мл по 1–2 капли или спрей 0,25 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

старше 6 лет – раствор 0,5 мг/мл по 1–2 капли или спрей 0,5 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

41.2. ксилометазолин (капли назальные 0,5 мг/мл; 1 мг/мл; спрей назальный 0,5 мг/мл; 1 мг/мл):

детям в возрасте 1–2 года – капли назальные 0,5 мг/мл, назначаются после оценки соотношения «польза–риск» по 1–2 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

2–11 лет – капли назальные 0,5 мг/мл по 1–2 капли или спрей назальный 0,5 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

старше 12 лет – капли назальные 1 мг/мл по 2–3 капли или спрей назальный 1 мг/мл по 1 впрыскиванию в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

41.3. нафазолин (капли назальные 0,5 мг/мл; 1 мг/мл):

7–11 лет – капли назальные 0,5 мг/мл – по 2–4 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней;

старше 12 лет – капли назальные 1 мг/мл – по 2–4 капли в каждый носовой ход 2–3 раза в сутки не более 7 дней.

42. С целью элиминационно–иригационной терапии назначается промывание полости носа официальными солевыми растворами.

43. При ОРС назначаются муколитические ЛП: ацетилцистеин (для детей старше 2 лет), сироп 20 мг/мл, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 100 мг, 200 мг, таблетки шипучие 200 мг, 600 мг – детям 2–12 лет – 100 мг 3 раза в сутки или 200 мг 2 раза в сутки, детям 6–12 лет – 200 мг 2 раза в сутки, старше 12 лет – 200 мг 3 раза в сутки. Продолжительность лечения – до 14 дней в зависимости от клинических симптомов.

44. В качестве дополнительного метода лечения, который выполняется врачом-оториноларингологом (при наличии технических возможностей) используется вакуумное дренирование ОНП (с использованием вакуумного аспиратора), которое заключается в одновременном введении в одну половину носа промывающего раствора и вакуумного «аспирирования» его из второй, обеспечивая циркуляцию раствора между пазухами и его воздействие непосредственно на очаг воспаления. Предварительно, за 10–15 минут до процедуры должны быть использованы назальные симпатомиметики согласно пункту 41 настоящего клинического протокола.

45. Выбор метода хирургического вмешательства и объем хирургического вмешательства осуществляется индивидуально на основании оценки результатов диагностических исследований.

Методами хирургического вмешательства при лечении ОРС являются:

пункция верхнечелюстной пазухи и (или) трепанопункции лобной пазухи;

эндоскопическая эндоназальная и (или) экстраназальная синус-хирургия.

46. Медицинские показания для пункции верхнечелюстной пазухи и (или) трепанопункции:

46.1. горизонтальный уровень жидкости на рентгенографии ОНП;

46.2. отсутствие эффекта от проводимой консервативной терапии;

46.3. выраженный болевой синдром, связанный с блоком соустья (с учетом данных рентгенографии (тотальное, субтотальное затемнение, в том числе с горизонтальным уровнем);

46.4. тяжелое течение острого верхнечелюстного синусита (с учетом данных рентгенографии (тотальное, субтотальное затемнение, в том числе с горизонтальным уровнем);

46.5. необходимость подтверждения риногенного и внутричерепного осложнения в сомнительных случаях;

46.6. взятие материала из верхнечелюстной пазухи для бактериологического исследования.

47. Медицинскими показаниями для эндоскопической эндоназальной синус хирургии или санации ОНП наружным доступом (эндоскопическим или не эндоскопическим) являются:

47.1. наличие или угроза развития орбитальных или внутричерепных осложнений;

47.2. отсутствие санации ОНП после пункционно-консервативного лечения через 7 дней.

48. При рецидивирующем течении ОРС (4 и более диагностированных эпизода ОРС в год) детям старше 3 лет выполняется аденотомия.